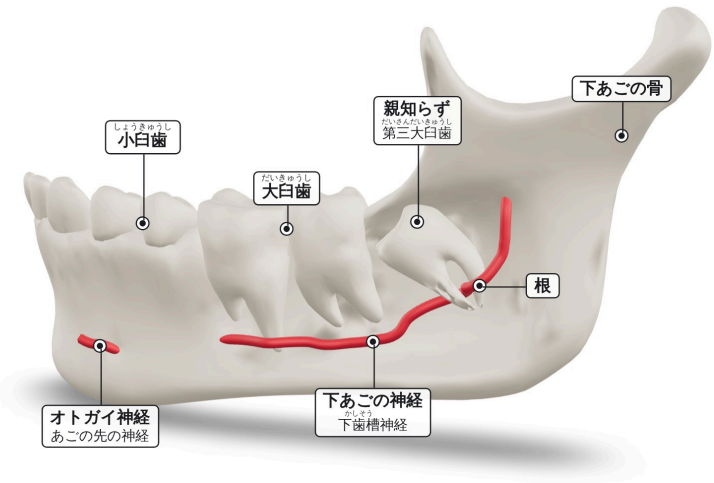
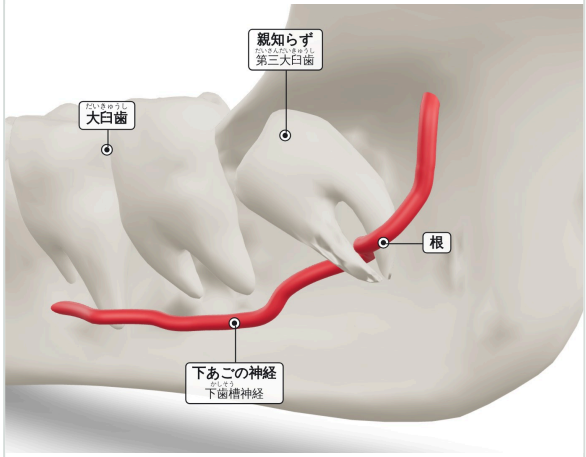
親知らずを抜くときの、神経が傷つくリスク

NAGOYA UNIVERSITY

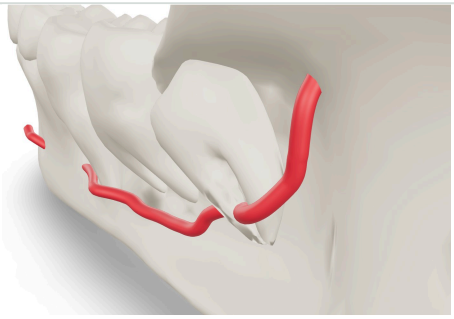
この親知らずの根は、神経に巻き付いています。歯を抜くと神経が傷つき、下唇やあごがしびれることがあります。



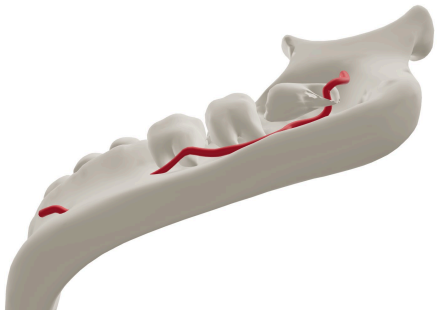
全体（ほお側）



根と神経（拡大）



後ろから見た根と神経



下から見た、骨の中の神経

どのような状態ですか？

親知らずは、最も奥に生える歯で、「**第三大臼歯**」とも呼ばれます。**埋まっている下の親知らず**は、歯ぐきと骨の中にあり、歯ぐきの上に出ていません。正しい向きに生えることができない状態です。

神経について

下あごの骨の中には細い管があり、その中を神経が通っています。ここでは「**下あごの神経**」と呼びます。医学用語では「**下歯槽神経**」といいます。同じ管の中を、血管（**下歯槽動脈**と**下歯槽静脈**）も一緒に通っています。[1]

下あごの神経は、同じ側の下の歯と歯ぐきの感覚を伝えています。[1] あごの前の方で、この神経の枝が骨の小さな穴から外に出ます。この枝を「**オトガイ神経**」と呼び、下唇とあごの感覚を伝えています。[2]

親知らずを抜くと、舌の神経（**舌神経**）が傷つくこともあります。[3] 1000人に1〜3人ほどは、障害が治らずに残る可能性があります。[4,5,6] このモデルでは、舌神経は示していません。

このモデルでは、**親知らずの根が神経と動脈に巻き付いています。**

抜歯で神経が傷つくのはなぜですか？

歯を抜くには、根を骨から取り出す必要があります。この歯の根は神経を囲むように曲がっているため、抜歯の際に神経が圧迫されたり、切れたりすることがあります。[7] 一緒に通っている動脈や静脈が傷つき、出血することもあります。[1,7]

下あごの神経が傷つくと、その枝であるオトガイ神経の働きも悪くなることがあります。[2]

神経が傷つくと、どうなりますか？

同じ側の下唇、あご、歯、歯ぐきに、次のような症状が出ることがあります。[7,3]



多くの人は、数週間から数か月で感覚が戻ります（**一時的**な障害）。ただし、感覚が完全には戻らない人もいます（**ずっと残る**障害）。[7,8,9]

年齢が高いほど神経が傷つきやすく、感覚も完全には戻りにくくなります。[7,10]

どのくらいの頻度で起こりますか？

根が神経に近い親知らずについては、多くの研究をまとめた報告がいくつかあります。報告によって差はありますが、次のとおりです。



100人中 約7人

歯を根まで全部抜いた後に、神経が傷つく可能性がある[9,11,12,7]

100人中 約1人

神経の傷が治らない可能性がある[9,8,13]

このような親知らずは、**口腔外科医**（口の手術の専門家）に診てもらうとよいでしょう。歯の状態を調べたうえで、抜くかどうかも含めて一緒に考えてくれます。[14]

参考にした論文 **1.** Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e2. doi.org/10.5037/jomr.2010.1102 **2.** Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e3. doi.org/10.5037/jomr.2010.1103 **3.** Renton T, Yilmaz Z. J Orofac Pain. 2011;25(4):333-344. PMID 22247929. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22247929 **4.** Lee J, Feng B, Park JS, et al. PLoS One. 2023;18(2):e0282185. doi.org/10.1371/journal.pone.0282185 **5.** Pichler JW, Beirne OR. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001;91(4):395-401. doi.org/10.1067/moe.2001.114154 **6.** Petroni G, Passaretti A, Zaccheo F, et al. Eur J Dent. 2021;15(4):776-781. doi.org/10.1055/s-0041-1730042 **7.** Sarikov R, Juodzbalys G. J Oral Maxillofac Res. 2014;5(4):e1. doi.org/10.5037/jomr.2014.5401 **8.** Kang F, Sah MK, Fei G. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2019;121(1):63-69. doi.org/10.1016/j.jormas.2019.06.010 **9.** Rico-Barroso L, Barroso-Medel M, Gutiérrez-Pérez J, et al. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2026;31(1):e19-e30. doi.org/10.4317/medoral.27459 **10.** Queral-Godoy E, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, et al. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;99(3):259-264. doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.06.001 **11.** Derbishi AA, Altayyar RA, Alsubaiei AS, et al. Cureus. 2026;18(3):e105646. doi.org/10.7759/cureus.105646 **12.** Kang FW, Yuan XR, Li GC, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2025;83(5):601-615. doi.org/10.1016/j.joms.2025.01.014 **13.** Cervera-Espert J, Pérez-Martínez S, Cervera-Ballester J, et al. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016;21(4):e505-e513. doi.org/10.4317/medoral.21074 **14.** Faculty of Dental Surgery, Royal College of Surgeons of England. Parameters of care for patients undergoing mandibular third molar surgery. London: RCS England; 2020. www.rcseng.ac.uk/-/media/Files/RCS/FDS/3rd-molar-guidelines--April-2021-v3.pdf

この資料は、名古屋大学の研究のためのものです。第3.0版（2026年10月29日）。